

PENGUNAAN KONTRASEPSI DAN KETERPAPARAN INFORMASI TERHADAP TINGKAT KELAHIRAN PADA USIA REMAJA

Winda Nurmayani • Ilham
Fitri Romadonika

PENGUNAAN KONTRASEPSI DAN KETERPAPARAN INFORMASI TERHADAP TINGKAT KELAHIRAN PADA USIA REMAJA

Winda Nurmayani M., S.Kep., Ners., MPH.

Hj. Ilham, S.Kep., Ners., M.Kep.

Fitri Romadonika.,S.Kep.,Ners.,M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**PENGUNAAN KONTRASEPSI DAN KETERPAPARAN INFORMASI TERHADAP
TINGKAT KELAHIRAN
PADA USIA REMAJA**

Penulis: Winda Nurmayani M., S.Kep., Ners., MPH.
Hj. Ilham, S.Kep., Ners., M.Kep.
Fitri Romadonika.,S.Kep.,Ners.,M.Kep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-53-5
Cetakan Pertama: Februari, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2025
by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : www.nuansafajarcemerlang.com
Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Penggunaan kontrasepsi dan keterpaparan informasi terhadap tingkat kelahiran pada usia remaja / Winda Nurmayani M., S.Kep., Ners., MPH., Hj. Ilham, S.Kep., Ners., M.Kep., Fitri Romadonika.,S.Kep.,Ners.,M.Kep.
EDISI	Cetakan pertama, Februari 2025
PUBLIKASI	Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 76 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-53-5
SUBJEK	Kontrasepsi -- Pendidikan seks untuk remaja -- Informasi, Ilmu
KLASIFIKASI	613.94 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1188091

Prakata

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "PENGUNAAN KONTRASEPSI DAN KETERPAPARAN INFORMASI TERHADAP TINGKAT KELAHIRAN PADA USIA REMAJA"

Buku ini membahas tentang pentingnya Kontrasepsi dan Keterpaparan Informasi tentang Kesehatan Reproduksi untuk mencegah kehamilan dan kelahiran pada remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting untuk kesehatan reproduksi karena dimasa ini akan di mulai pembentukan perilaku, dimana remaja mulai mencoba sesuatu yang baru ataupun menantang, termasuk dalam kaitannya dengan perilaku kesehatan. Remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang beresiko seperti melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah. Remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media masa dan elektronik.

Apa itu kontrasepsi, macam-macam kontraspesi, efek kontrasepsi, kehamilan remaja, dampak kehamilan remaja, keterpaparan informasi dalam buku ini akan dibahas lebih detail.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi para remaja untuk peduli dengan kesehatan reproduksinya.
Selamat membaca

(Desember, 2024)

Penulis

Daftar Isi

Prakata..... iii

Daftar Isi..... iv

Bab 1 Pendahuluan 1

Bab 2 Penggunaan Kontrasepsi 7

A. Pengertian Kontrasepsi.....7

B. Macam-Macam Kontrasepsi.....8

1. Metode Sederhana.....8

2. Metode KB Efektif..... 13

C. Efek Samping Kontrasepsi..... 16

Bab 3 Keterpaparan Informasi 20

A. Keterpaparan Informasi..... 20

B. Sumber Informasi 24

C. Informasi terkait Keterpaparan Informasi..... 30

Bab 4 Kelahiran Pada Remaja 32

A. Remaja 32

B. Tahap Perkembangan Pada Remaja..... 35

C. Perkembangan Fisik Remaja..... 37

D. Perkembangan Psikologis Remaja 39

E. Seksualitas Pada Remaja..... 40

F. Pernikahan Pada Remaja (Pernikahan Dini)..... 44

G. Kehamilan Pada Usia Remaja 45

H. Dampak Kehamilan Pada Remaja..... 47

I. Melahirkan Pada Usia Remaja..... 48

J. Dampak Melahirkan Pada Usia Remaja..... 49

K. Studi terkait Kelahiran Pada Remaja 52

Bab 5 Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi dan Keterpaparan Informasi Terhadap Kelahiran Remaja .. 55

 A. Penggunaan Kontrasepsi Terhadap Kelahiran Remaja 55

 B. Pengaruh Keterpaparan Informasi Terhadap Kelahiran Remaja 58

Bab 6 Penutup 61

Daftar Pustaka 63

Glosarium 70

Profil Penulis..... 73

Bab 1

Pendahuluan

Permasalahan kependudukan, khususnya pertumbuhan penduduk yang pesat, menjadi isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, di antaranya Indonesia. Isu kependudukan ini juga menjadi tantangan bagi hampir semua negara berkembang di dunia, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran. Meningkatnya jumlah penduduk secara drastis berimbas pada berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan dengan cara mengatur tingkat kelahiran serta mengurangi angka kematian bayi dan anak. Keberhasilan seorang wanita atau kelompok wanita dalam melahirkan bayi hidup disebut sebagai fertilitas. Fertilitas merupakan komponen kunci dalam pertumbuhan penduduk suatu wilayah, di samping faktor migrasi. Penting untuk dipahami bahwa tingkat kelahiran pada masa lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesuburan pada generasi sekarang (Mahendra 2017).

Di skala global, kehamilan remaja merupakan masalah sosial yang kompleks dan berdampak luas, khususnya di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Sekitar 1 dari 8 kelahiran dari total 140 juta kelahiran setiap tahun terjadi pada remaja perempuan, dengan 95% di antaranya terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO 2020). Kehamilan pada remaja dapat menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (e Silva and Surita 2017; Maravilla, Betts, and Alati 2019). Fenomena kehamilan remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang serius, dengan angka kejadian yang sangat tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Setiap tahun, jutaan remaja perempuan berusia 15-19 tahun dan bahkan di bawah 16 tahun melahirkan bayi, yang berimplikasi pada berbagai masalah kesehatan dan sosial (WHO 2018).

Menurut kajian yang dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun 2017 dan studi lain oleh Raharja pada tahun 2015, kelahiran pada usia remaja diukur dengan menghitung jumlah kelahiran yang terjadi pada setiap 1.000 perempuan berusia 15 hingga 19 tahun. Angka ini secara khusus disebut sebagai ASFR untuk kelompok usia remaja (BKKBN, 2018).

Menurut hasil Kemenkes (2012) dan SDKI 2012, terjadi peningkatan fertilitas remaja di Indonesia, dengan persentase remaja perempuan usia 15-19 tahun yang telah melahirkan atau hamil untuk pertama kalinya mencapai 10% (BPS, 2013). Sementara itu, data SDKI 2017 menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Spesifik Usia (ASFR) untuk kelompok usia 15-19

tahun di tingkat nasional adalah 36 per 1000 perempuan. Provinsi dengan ASFR tertinggi adalah Kalimantan Tengah, yakni 83 per 1000 perempuan, sementara yang terendah adalah DI Yogyakarta dengan 15 per 1000 perempuan. Di Provinsi NTB, ASFR tercatat sebesar 42 per 1000 perempuan, yang menunjukkan bahwa NTB masih berada di atas rata-rata nasional (BKKBN, 2017).

Kejadian kelahiran pada remaja dipengaruhi oleh sejumlah aspek yang saling terkait. Aspek-aspek tersebut antara lain usia remaja, usia saat memasuki pernikahan pertama, riwayat pernikahan sebelumnya, status ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi, tingkat pendidikan, dan sejumlah aspek sosial lainnya (Mahendra 2017). Kelahiran pada remaja dipengaruhi oleh faktor usia, tempat tinggal, kuantil kekayaan, dan tingkat pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat fertilitas, karena pendidikan berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, usia kawin pertama, yaitu usia saat seseorang menikah untuk pertama kali, juga berperan penting. Wanita yang menikah di usia muda memiliki rentang waktu lebih lama untuk berisiko hamil, yang menyebabkan angka kelahiran lebih tinggi (Sinaga, Hardiani, and Prihanto 2017).

Selain itu, faktor-faktor seperti lokasi tempat tinggal, usia saat pertama kali berhubungan seksual, usia saat melahirkan anak pertama, dan kemiskinan dapat mempengaruhi kelahiran pada remaja. Kemiskinan bisa mengurangi kemampuan anak perempuan untuk membuat

keputusan terkait kelahiran berikutnya, penggunaan kontrasepsi, akses ke aborsi, atau bahkan mendorongnya untuk membatasi jumlah anak lebih awal karena terbatasnya pilihan yang tersedia (Aslam et al. 2017).

Masa remaja adalah periode perkembangan aktif di mana individu mengalami pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Fase ini dimulai sekitar usia 10 tahun dan berakhir pada usia 19 tahun, menandai peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Banyak remaja menghadapi tekanan untuk memulai hubungan seksual pada usia dini, yang membuat mereka berisiko tinggi terhadap konsekuensi seperti penyakit kelamin menular dan kehamilan yang tidak terencana. Kehamilan di usia muda meningkatkan risiko bagi ibu dan bayinya, serta dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang negatif bagi remaja perempuan, keluarga, dan masyarakat (Korenčan et al. 2017). Proses melahirkan pada remaja dapat mempengaruhi kesehatan ibu secara fisik dan mental. Dampak fisik yang mungkin terjadi meliputi kelahiran prematur, korioamionitis, endometritis, preeklamsia berat, eklamsia, perdarahan pasca-persalinan, gangguan pertumbuhan janin, gawat janin, bahkan hingga kematian (Socolov *et al*, 2017).

Kehamilan di usia remaja telah menjadi permasalahan global yang serius, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah menjadi fokus perhatian dunia internasional, seperti yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu tujuan SDGs

adalah untuk mengakhiri perkawinan anak dan remaja serta mencapai kesetaraan gender. Masa remaja, yang merupakan periode transisi penting dalam kehidupan manusia, ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis yang signifikan, termasuk perkembangan seksual (BKKBN, 2019).

Upaya bersama di tingkat global telah diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi kerangka kerja yang komprehensif dalam mencapai tujuan ini, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan yang dibutuhkan (BKKBN, 2019). Salah satu program yang mendukung hal ini adalah program KRR, yang mengimplementasikan kedua strategi tersebut melalui PIK-KRR. PIK-KRR merupakan wadah yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja dalam memberikan informasi serta layanan konseling terkait kesehatan reproduksi. Jika masalah yang dihadapi remaja tidak dapat ditangani di PIK-KRR, mereka dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih lengkap.

BKKBN memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan kependudukan. Upaya yang dilakukan BKKBN meliputi: (1) membangun jejaring kerja yang luas untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam program kependudukan; (2) mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi; (3) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur; (4) mengatur pertumbuhan

penduduk agar seimbang dengan daya dukung lingkungan; (5) menyediakan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif; dan (6) membangun keluarga yang berkualitas melalui pendekatan yang holistik dan integratif (BKKBN, 2019).

Kebijakan kependudukan merupakan seperangkat strategi yang dirancang untuk mempengaruhi dinamika demografi suatu negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks global yang semakin kompleks, kebijakan kependudukan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Heri& Cicih, 2019).

SKAP merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program KKBPK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Survei ini secara khusus mengukur kinerja program dalam tiga aspek utama, yaitu kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Data *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) untuk usia 15-19 tahun menunjukkan angka 30% pada tahun 2018, sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi 33%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka kelahiran pada remaja antara tahun 2018 dan 2019.

Bab 2

Penggunaan Kontrasepsi

A. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata 'kontra' yang berarti 'melawan' dan 'konsepsi' yang berarti 'pembuahan'. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu upaya untuk mengatur jarak kelahiran, merencanakan keluarga, dan menjaga kesehatan reproduksi. Cara kerja kontrasepsi sangat beragam, namun semuanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pembuahan, sehingga kehamilan dapat direncanakan sesuai dengan keinginan pasangan (Wiknjosastro 2007).

Menurut Hartanto (2004) pelayanan kontrasepsi membantu pasangan untuk merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal. Metode keluarga berencana alami merupakan pendekatan non-farmakologis yang telah lama digunakan untuk mengatur jarak kehamilan. Metode ini didasarkan pada prinsip pemantauan siklus menstruasi dan identifikasi masa subur wanita. Dengan cara ini, pasangan dapat merencanakan hubungan seksual sesuai dengan tujuan

reproduksi yang diinginkan, baik untuk mencegah kehamilan maupun untuk meningkatkan peluang kehamilan (Everett 2020).

B. Macam-Macam Kontrasepsi

1. Metode Sederhana

Strategi pencegahan dasar adalah teknik yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang mengatur sendiri, tanpa penilaian klinis sebelumnya. Hasil yang didapat dengan cara ini sebagian besar kurang kuat dibandingkan teknik lainnya.

Metoda kontrasepsi sederhana tanpa obat/alat:

a. Metode Amenorea Laktasi (MAL)

Kontrasepsi menyusui adalah cara pencegahan kehamilan alami yang memanfaatkan proses biologis menyusui. Cara ini mengandalkan pemberian ASI murni, di mana bayi hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama jangka waktu tertentu.

b. Senggama terputus (koitus interruptus)/ *withdrawal methods* atau *pull-out method*.

Teknik dimana pria menarik penisnya keluar dari vagina sebelum ejakulasi, sehingga sperma dikeluarkan di luar tubuh dan tidak masuk ke dalam saluran vagina.

c. Pantang berkala/metode kalender

Merupakan metode yang sederhana dan tidak memerlukan alat atau obat-obatan. Metode ini hanya

bergantung pada pengamatan gejala kesuburan tubuh wanita. Metode ini juga dikenal sebagai metode ritme atau perhitungan siklus menstruasi, yang dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah hari dalam setiap siklus, dimulai dari hari pertama menstruasi.

Penghitugan masa subur:

Siklus tepanjang – 11 hari, untuk menghitung akhirmasa suburnya.

Siklus terpendek – 18 hari, untuk menghitung awal dr masa suburnya

Ex: Siklus terpanjang 30 hari dan terpendek 28 hari.

$$\rightarrow 30 - 11 = 19$$

$$\rightarrow 28 - 18 = 10$$

Masa subur 10-19

Masa tdk subu 20 $\rightarrow$ 9

d. Suhu Basal

Mengukur suhu basal adalah metode kontrasepsi yang melibatkan pemantauan perubahan suhu tubuh untuk menentukan periode ovulasi. Teknik ini mengandalkan perkiraan kenaikan suhu tubuh untuk mengidentifikasi waktu ovulasi. Keberhasilan metode suhu basal cukup tinggi, dengan tingkat kegagalan berkisar antara 0,3 hingga 6,6 kehamilan per 100 wanita setiap tahun.

Pengukuran suhu basal dilakukan saat suhu tubuh berada pada titik terendah dalam keadaan

istirahat (tidur), yang disebut suhu basal. Pencatatan suhu basal bertujuan untuk menentukan kapan masa subur atau ovulasi terjadi. Perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu ini adalah termometer basal, yang digunakan untuk memperkirakan perubahan suhu tubuh internal.

Untuk mendapatkan data suhu basal tubuh yang reliabel, disarankan untuk selalu menggunakan metode pengukuran yang sama dan pada waktu yang sama setiap hari. Suhu tubuh basal yang normal umumnya berada dalam rentang 35,5 hingga 36 derajat Celcius. Pada saat ovulasi, suhu tubuh akan turun terlebih dahulu, lalu meningkat menjadi antara 37 hingga 38 derajat Celsius. Perubahan ini terjadi karena penurunan produksi progesteron.

e. Metode Lendir Servik (metode ovulasi bilings/MOB)

Metode kontrasepsi ini melibatkan pengamatan terhadap perubahan cairan serviks wanita yang dapat dilihat di vulva. Pola yang diamati memungkinkan setiap wanita untuk memprediksi periode ovulasi dengan akurat tanpa perlu memantau suhu tubuh basal. Perubahan pada siklus lendir serviks ini terjadi sebagai akibat dari fluktuasi kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh.

f. Metode Sympto Thermal

Metode Simtothermal adalah metode pengaturan keluarga alami (KBA) yang mengidentifikasi masa subur berdasarkan siklus kewanitaan wanita. Metode

ini menggabungkan pengamatan terhadap mukosa serviks dan suhu tubuh basal. Teknik ini melibatkan tiga tanda utama, yaitu perubahan suhu tubuh basal, perubahan cairan atau mukosa serviks, serta perkiraan masa subur dengan menggunakan metode jadwal.

g. Kondom

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan tipis dan elastis seperti lateks atau poliuretan. Bentuknya seperti tabung dengan ujung yang tertutup rapat. Kondom berfungsi sebagai penghalang fisik untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Sebagian besar kondom terbuat dari bahan elastis atau plastik tipis, meskipun ada juga yang terbuat dari jaringan hewan (seperti dari sistem pencernaan kambing) atau plastik. Fungsi utama kondom adalah melindungi penis selama hubungan seksual dan mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Kondom berbentuk tabung dengan ujung terbuka yang memiliki tepi tebal, sementara bagian tertutup berfungsi untuk menampung sperma. Ukuran kondom biasanya memiliki lebar sekitar 31-36,5 mm dan panjang sekitar 19 mm, dan sering kali dilapisi dengan pelicin yang bersifat spermatisid.

h. Kondom wanita

Kondom wanita adalah alat kontrasepsi yang memberikan kontrol lebih besar kepada perempuan. Kondom ini berbentuk kantong tipis yang terbuat dari bahan sintesis dan memiliki dua cincin di kedua

ujungnya. Cincin bagian dalam membantu menjaga kondom tetap berada di tempatnya, sementara cincin bagian luar menutupi vulva. Selain mencegah kehamilan, kondom wanita juga memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual.

i. Diafragma (Diaphragma)

Diafragma lateks (karet) adalah penutup cembung berbentuk bulat yang menutupi serviks dan dimasukkan ke dalam vagina sebelum hubungan seksual. Beberapa jenis diafragma yang ada antara lain: *Flat spring*, *Coil spring*, dan *Archling spring*.

j. Kap Servik

Penutup serviks merupakan alat kontrasepsi barrier yang berfungsi sebagai penghalang fisik antara vagina dan rahim, mencegah sperma mencapai sel telur. Dibandingkan dengan perut, penutup serviks terletak lebih dalam atau lebih tinggi di bagian atas namun lebih sempit lebarnya, serta umumnya memiliki bentuk yang lebih lurus. Pada masa lalu, penutup serviks dibuat dari bahan logam atau plastik, namun saat ini sebagian besar terbuat dari bahan elastis.

k. Kimiawi (Spermisida)

Spermisida merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk menghentikan pergerakan sperma dan membuatnya tidak mampu membuahi sel telur. Zat ini tersedia dalam berbagai bentuk, seperti semprotan

(buih), tablet vagina, supositoria, film yang larut, atau krim.

2. Metode KB Efektif

Metode kontrasepsi modern menggunakan berbagai cara untuk mengganggu proses reproduksi, seperti mencegah ovulasi, melumpuhkan sperma, atau menghalangi implantasi. Dengan pengertian yang jelas tentang metode kontrasepsi modern, berbagai produk dan pendekatan dapat dikelompokkan dengan mudah. Metode yang tidak memenuhi definisi ini dianggap tidak sesuai dengan konsep kontrasepsi modern. Metode KB yang efektif melibatkan penggunaan obat, suntikan, atau alat yang dapat mencegah kehamilan secara efektif.

Komposisi KB efektif

Hormon Progesti

Kontrasepsi hormonal progestin adalah metode pencegahan kehamilan yang menggunakan hormon buatan yang menyerupai progesteron alami dalam tubuh perempuan. Metode ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti tablet, suntikan, dan susuk. Dengan menghalangi ovulasi serta menyebabkan perubahan pada cairan serviks, pengendalian kelahiran progestin efektif dalam mencegah konsepsi.

a. Suntik

- 1) Kontrasepsi ini menggunakan hormon progestin sintetis yang memiliki fungsi serupa dengan hormon progesteron alami dalam tubuh wanita.
- 2) Kontrasepsi Suntik Kombinasi (KSK)
Yakni kombinasi hormon progestin dan estrogen sintetis untuk mencegah kehamilan. Hormon-hormon ini bekerja sama untuk menghambat ovulasi dan membuat perubahan pada dinding rahim.

b. PIL

1) Pil Kombinasi (KPK)

Merupakan kontrasepsi hormonal yang terdiri atas dua jenis hormon buatan, yaitu progestin dan estrogen. Hormon-hormon ini menyerupai hormon alami perempuan dan berperan dalam mencegah konsepsi. Obat ini harus dikonsumsi secara rutin setiap hari untuk mencapai efektivitas tertinggi..

(1) Monofasik

Pil kontrasepsi jenis ini memiliki kandungan hormon yang konsisten pada setiap butir pil, sehingga penggunaannya lebih mudah diingat.

(2) Bifasik

Pil bifasik mengandung dua jenis tablet yang harus diminum secara bergantian. Setiap jenis tablet memiliki kandungan hormon yang

berbeda untuk menyesuaikan dengan fase siklus menstruasi.

(3) Trifasik

Pil trifasik merupakan jenis pil kontrasepsi yang paling banyak digunakan karena dianggap lebih menyerupai siklus menstruasi alami.

(4) Kuadrifasik

Pil kuadrifasik merupakan jenis pil kontrasepsi yang paling baru dan memiliki empat fase yang berbeda dalam satu kemasan.

2) Pil kontrasepsi

Tablet pencegah kehamilan darurat berperan dalam menghentikan sementara proses reproduksi perempuan dengan menunda atau menghalangi pelepasan sel telur.

c. Implant

Implan pencegah kehamilan adalah cara pengendalian kehamilan jangka panjang yang efisien. Alat ini berbentuk batang kecil berisi hormon progestin dan mampu bertahan hingga beberapa tahun dalam tubuh.

d. AKDR (alat kontrasepsi dalam Rahim)

Merupakan perangkat medis yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. AKDR bekerja dengan cara mencegah fertilisasi atau implantasi ovum yang telah dibuahi.

C. Efek Samping Kontrasepsi

Para peneliti telah mengungkapkan bahwa efek samping seperti mual atau muntah, nyeri payudara, perubahan suasana hati, kenaikan berat badan, pusing, dan sakit kepala dapat menyebabkan penghentian penggunaan kontrasepsi oral (OCs). Di Afrika Selatan, masalah seperti amenore, keputihan/perpindahan vagina, penambahan berat badan, dan bercak dapat menyebabkan penghentian sementara penggunaan kontrasepsi suntik, sedangkan wanita di Honduras melaporkan masalah seperti kenaikan berat badan, pusing, atau perdarahan berat.

Pengendalian kehamilan hormonal, meskipun efisien, memiliki sejumlah dampak samping yang harus diwaspadai. Pergeseran pola haid, peningkatan berat tubuh, serta keterlambatan pemulihan kesuburan merupakan beberapa dampak samping yang kerap dilaporkan oleh pemakai. Dampak ini umumnya disebabkan oleh perubahan hormon yang dipicu oleh penggunaan pengendalian kehamilan hormonal (Putri 2020; Rusmini et al., 2017).

Walaupun mayoritas dampak samping pengendalian kehamilan hormonal bersifat ringan, tidak semua perempuan mengalami dampak serupa. Beberapa dampak yang berpotensi muncul dapat memengaruhi kenyamanan hidup. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap perempuan untuk berdiskusi dengan tenaga medis sebelum memakai pengendalian kehamilan hormonal guna memahami risiko dan keuntungannya secara lebih rinci.

Jenis hormon yang terkandung dalam kontrasepsi hormonal dapat memengaruhi jenis efek samping yang muncul. Misalnya, kontrasepsi yang mengandung progestin seringkali menyebabkan perubahan pada siklus menstruasi, sedangkan kontrasepsi yang mengandung estrogen dapat memicu munculnya jerawat atau perubahan warna kulit. Selain itu, kedua jenis hormon ini juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada beberapa pengguna (Sety, 2017).

Efek samping yang muncul akibat penggunaan kontrasepsi suntik bulanan umumnya disebabkan oleh perubahan hormonal dalam tubuh. Perubahan hormon ini dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi, seperti perdarahan yang tidak teratur atau tidak adanya menstruasi. Selain itu, beberapa pengguna juga mungkin mengalami keluhan fisik lainnya seperti sakit kepala atau nyeri payudara (Matahari et al. 2019; Nabila and Ulfa 2015).

Menurut Putri and Nikmah (2021), pemakaian injeksi kontrasepsi tiga bulan bisa memunculkan beragam dampak samping, baik untuk durasi singkat maupun durasi panjang. Pada durasi singkat, pengguna berpeluang menghadapi ketidakstabilan menstruasi, fluktuasi berat tubuh, atau persoalan dermatologis. Pada durasi panjang, pemakaian injeksi kontrasepsi untuk kurun waktu lama bisa memperbesar risiko pengeroposan tulang pada sebagian perempuan.

Pil kontrasepsi adalah metode kontrasepsi kedua yang paling banyak dipilih oleh responden, dan juga umum

digunakan di Indonesia. Banyak wanita usia subur memilih pil KB karena alasan utamanya adalah harganya yang terjangkau dan mudah diakses, serta tidak memerlukan kunjungan ke tenaga medis untuk penggunaannya. Selain itu, pil KB juga tidak mengganggu kesuburan jangka panjang, sehingga wanita dapat hamil lagi dengan cepat setelah berhenti mengonsumsinya. Meskipun demikian, efek samping yang sering dialami oleh pengguna pil KB termasuk mual pada awal pemakaian, jerawat, migrain, sakit kepala ringan, perubahan mood, dan penambahan berat badan. Kajian yang dilaksanakan oleh Setiawati, Prasetyaningrum, and Alit (2020), juga menemukan bahwa dampak samping yang paling kerap dilaporkan oleh pemakai pil kontrasepsi oral ialah kenaikan bobot tubuh dan nyeri kepala ringan. Dampak samping ini biasanya bersifat sementara dan dapat berbeda-beda pada tiap individu. (Matahari et al. 2019).

Penggunaan kontrasepsi implan dapat memicu berbagai perubahan dalam tubuh, termasuk gangguan pada siklus menstruasi. Beberapa wanita mungkin mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi (spotting), perdarahan yang lebih banyak atau lebih lama (menoragia), atau bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali (amenore). Selain itu, efek samping lain yang mungkin muncul adalah perubahan berat badan, nyeri payudara, sakit kepala, perubahan suasana hati, dan perasaan mual. Selain itu, keterbatasan dari metode kontrasepsi ini adalah bahwa akseptor tidak bisa mencabut sendiri implan jika

ingin berhenti menggunakannya. Untuk melakukannya, akseptor harus pergi ke klinik, bidan, atau dokter spesialis kandungan agar prosedur pencabutan dan pemasangan dapat dilakukan. (Rusmini, Utami, and Fauziah 2017).

Beberapa efek samping penggunaan IUD antara lain adalah munculnya perdarahan pervaginam dalam bentuk bercak-bercak (spotting). Selain itu, kadang-kadang juga terjadi peningkatan keputihan. Pada saat berhubungan seksual, IUD juga dapat mengalami perubahan posisi, baik sebagian maupun seluruhnya (Maskanah,2009)

Bab 3

Keterpaparan Informasi

A. Keterpaparan Informasi

Keterpaparan informasi merujuk pada segala bentuk informasi yang disebarkan melalui media massa, baik berupa hiburan maupun pengetahuan, yang dapat memengaruhi gaya hidup seseorang, baik secara positif maupun negatif. Beberapa contoh sumber informasi meliputi: internet, media elektronik, media cetak, tenaga kesehatan, keluarga, dan teman sebaya.

Dunia kini semakin dikuasai oleh remaja akibat perkembangan informasi yang begitu cepat dalam berbagai bentuk. Hal ini juga berlaku pada informasi mengenai kebudayaan di suatu negara terkait hubungan seksual, yang telah mempengaruhi pola pikir remaja, termasuk di Indonesia. Sebagai hasilnya, terjadi perubahan yang mengarah pada semakin bebasnya perilaku seksual pranikah di kalangan remaja (Manuaba, 2016).

Penting untuk memberikan edukasi seks yang komprehensif kepada remaja agar mereka dapat memahami tentang seksualitas dengan benar.

Sayangnya, seringkali remaja lebih banyak terpapar informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan usia mereka melalui media massa. Hal ini dapat menyebabkan miskonsepsi tentang seksualitas dan meningkatkan risiko perilaku seksual yang berisiko (Afriani 2016).

Hubungan seksual pranikah pada remaja dapat dicegah jika mereka menerima informasi dan pendidikan seksual yang tepat dari sumber yang dapat dipercaya (Anggriyani Wahyu Pinandari, Wilopo, and Ismail 2015). Di era sekarang, banyak konten yang menyajikan informasi tersembunyi yang mengandung unsur pornografi, yang dapat meningkatkan minat dan ketertarikan remaja untuk terlibat dalam seks pranikah (A. P. Dewi 2012). Paparan konten seksual yang eksplisit melalui media massa dapat memicu perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan etika. Konten pornografi yang seringkali disajikan secara vulgar dapat memberikan informasi yang menyesatkan tentang seksualitas, sehingga meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko pada remaja.

Sesuai dengan Nurmayani et al. (2024) tingkat keterpaparan remaja terhadap informasi tentang perilaku seksual pranikah terbagi dalam kategori kurang, yaitu 787 orang (80,1%), cukup sebanyak 70 orang (17,3%), dan baik sejumlah 25 orang (2,5%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber informasi sangat mempengaruhi kualitas informasi yang diterima. Kesulitan dalam menyaring informasi yang akurat muncul karena banyaknya akses informasi dari berbagai media. Keakuratan informasi sangat bergantung

pada siapa yang menyampaikannya dan bagaimana cara penyampaian (Rohmawati, 2020). Media massa dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja, karena meskipun media menyampaikan informasi edukasi yang akurat, remaja terkadang menyalahgunakan informasi tersebut (Istawati 2017). Kekurangan informasi mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Banyak remaja yang tidak memahami pentingnya kesehatan reproduksi bagi kesehatannya (Istawati 2017). Kekurangan informasi mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Banyak remaja yang tidak memahami pentingnya kesehatan reproduksi bagi kesehatannya. Menurut Ahiyanasari and Nurmala (2017) minat remaja terhadap informasi mengenai seks pranikah, termasuk dampak dan pencegahannya, masih tergolong rendah. Sebaliknya, mereka lebih tertarik untuk mengakses konten hiburan dan sosial media. Hal ini menunjukkan bahwa remaja kurang menyadari pentingnya memiliki pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi.

Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah merupakan intervensi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan seksual. Selain itu, diperlukan adanya sinergi antara berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja dalam mengakses informasi yang akurat dan

layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas (Chepkoech, Khayesi, and Ogola 2019).

Menurut penelitian di India, perilaku kesehatan seksual dan reproduksi (SRH) yang kurang baik di kalangan remaja perempuan disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang SRH. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat mendorong remaja untuk mencari informasi kesehatan, namun pengaruh media sosial terhadap pengetahuan SRH hanya memberikan manfaat bagi remaja perempuan yang terdidik, tinggal di kota, dan berasal dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi (Saha et al. 2022).

Sebuah penelitian di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa guru merupakan sumber informasi utama bagi remaja dalam hal kesehatan reproduksi. Sebanyak 72% remaja di daerah tersebut menyebutkan guru sebagai sumber informasi yang paling sering mereka andalkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian global yang menunjukkan bahwa remaja cenderung mempercayai guru sebagai sumber informasi yang terpercaya mengenai isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi (Donaldson et al. 2013). Selain guru, teman sebaya juga menjadi sumber informasi yang cukup signifikan bagi remaja dalam hal kesehatan reproduksi. Hasil penelitian di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa 34,2% remaja mendapatkan informasi dari teman atau saudara. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Turki yang menunjukkan bahwa teman sebaya menjadi salah satu sumber informasi utama bagi remaja,

meskipun seringkali informasi yang diperoleh tidak selalu akurat dan komprehensif.

B. Sumber Informasi

1. Media Sosial

a. Definisi

Platform digital telah mengubah secara radikal metode kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Sarana-sarana jejaring sosial seperti X (sebelumnya Twitter), Meta (sebelumnya Facebook), serta jurnal daring memungkinkan pemakai untuk mendistribusikan data, pemikiran, dan kisah secara cepat sekaligus efektif. Lebih lanjut, jejaring sosial turut mempermudah kerja sama serta penciptaan kelompok maya. (Monika et al. 2021). Maraknya dan membludaknya pengguna media sosial di kalangan remaja, tetap harus menyaring atau menelaah oleh karenanya yang harus di perhatikan adalah sumber informasinya (Kertanegara et al. 2020).

b. Karakteristik Media Sosial

Menurut Nasrullah (2017) Media sosial telah berevolusi dari pemahaman bahwa teknologi dapat menjembatani interaksi sosial. Ciri khas yang membedakannya dari media lain meliputi:

1) Jaringan (*Network*)

Sebagai entitas sosial, pengguna media sosial terikat dalam suatu jaringan virtual. Struktur

sosial media sosial didasarkan pada interkoneksi antar pengguna yang dimediasi oleh perangkat teknologi. Salah satu ciri utama dari jejaring sosial adalah terbentuknya koneksi antar pengguna. Meskipun pengguna di dunia nyata (offline) mungkin tidak saling mengenal, jejaring sosial memberikan cara bagi mereka untuk terhubung melalui teknologi. (Kertanegara et al. 2020).

2) Informasi

Informasi adalah kunci dalam media sosial. Pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi dan membagikannya. Interaksi dan identitas pengguna dibentuk oleh informasi yang mereka miliki dan bagikan. Bahkan, informasi telah menjadi semacam mata uang di dunia maya.

3) Arsip

Arsip berperan sebagai penyimpanan permanen bagi informasi yang dibagikan di media sosial. Pengguna dapat mengakses informasi ini kapan saja dan dari perangkat apa pun. Sebagai contoh, unggahan di Facebook disimpan dalam arsip digital yang dapat diakses kapan pun diperlukan (Nasrullah 2017).

4) Interaksi

Hubungan pada sarana jejaring sosial biasanya bersifat singkat, sering kali hanya dalam bentuk

tanda-tanda atau ulasan pendek. Sifat hubungan ini menjadi salah satu ciri pembeda utama antara jejaring sosial dan saluran komunikasi konvensional.

5) Simulasi Sosial

Media sosial adalah ruang publik digital di mana orang-orang berinteraksi. Sama seperti dunia nyata, dunia maya juga memiliki aturan dan etika. Media sosial tidak hanya mencerminkan realitas, tapi juga membentuk realitas baru (Nasrullah 2017).

6) Konten oleh pengguna

Media sosial ditandai oleh kehadiran konten yang dihasilkan pengguna (UGC). Fenomena ini menunjukkan pergeseran peran audiens dari sekadar konsumen menjadi produsen konten. Akibatnya, terbentuklah suatu budaya partisipatif di mana pengguna secara aktif terlibat dalam proses produksi dan konsumsi konten.

7) Penyebaran (*share*)

Streaming atau berbagi adalah fitur lain dari media sosial. Berbagi memungkinkan pengguna untuk secara aktif menyebarkan dan mengembangkan konten. Misalnya, pengguna media sosial tidak hanya memberikan pendapat, tapi juga bisa berbagi informasi terkini. Selain

itu, pengguna juga berperan dalam menyebarkan konten yang mereka temukan.

2. Aplikasi-aplikasi media sosial

Berbagai aplikasi di media sosial kini telah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian orang, bahkan mereka merasa canggung jika tidak menggunakannya. Mengakses aplikasi jejaring sosial setiap hari telah menjadi hal yang biasa saat ini. Berikut adalah beberapa aplikasi jejaring sosial yang paling banyak digunakan oleh remaja:

a. Facebook

Facebook merupakan jaringan sosial yang amat terkenal di dunia digital, bahkan digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Facebook berfungsi sebagai platform yang menghubungkan individu satu sama lain di dunia digital. Facebook diluncurkan pada Februari 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg, dan mulai dapat diakses oleh publik pada tahun 2006 (Kertanegara et al. 2020)

b. Twitter

Twitter adalah platform jejaring sosial berbasis microblogging yang diluncurkan pada Maret 2006 dan didirikan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, serta Biz Stone. Awalnya, konsep Twitter adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna mengirim pesan yang bisa disebar ke seluruh teman. Setelah melalui berbagai diskusi dan perbaikan,

Twitter kini berkembang menjadi layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk memposting pesan singkat atau status, yang mirip dengan SMS, dan dapat diakses secara online. (Rosenberg, Syed, and Rezaie 2020).

c. Youtube

YouTube, yang diperkenalkan pada Mei 2005, telah mempermudah jutaan individu untuk mencari, menonton, serta membagikan beragam jenis klip video. Platform ini juga menjadi saluran distribusi bagi para pembuat konten, baik yang menghasilkan karya asli maupun bagi pengiklan besar maupun kecil. YouTube merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Google (Rosenberg, Syed, and Rezaie 2020). YouTube telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berbagi video, dari film pendek hingga vlog. Dengan kemudahan penggunaan dan biaya yang terjangkau, YouTube menjadi platform populer bagi para pembuat konten. Hal ini memberikan kebebasan bagi videografer amatir untuk mengunggah dan membagikan video mereka dengan lebih mudah (Rosenberg, Syed, and Rezaie 2020)

d. Instagram

Instagram merupakan platform berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengedit gambar secara kreatif. Diluncurkan pada tahun 2010, aplikasi ini dengan cepat meraih

popularitas di kalangan pengguna perangkat mobile, terutama pengguna iOS. Instagram dikembangkan oleh perusahaan rintisan Burbn Inc. yang kemudian berfokus penuh pada pengembangan aplikasi ini. Ikon baru tersebut terinspirasi dari ikon aplikasi sebelumnya, berupa kamera sederhana dengan pelangi yang tampil dalam gradien warna yang cerah. (C. G. Dewi and Ibrahim 2019).

e. Whatsapp

WhatsApp, program pengiriman pesan langsung yang terkenal, dirancang oleh dua mantan pegawai Yahoo, yaitu Jan Koum dan Brian Acton. Setelah diambil alih oleh Facebook, WhatsApp terus maju dan menyediakan beragam fasilitas, mencakup pengiriman teks, foto, rekaman video, serta panggilan audio. Perlindungan interaksi pengguna menjadi fokus utama WhatsApp, yang diterapkan melalui penyandian ujung-ke-ujung. (Kertanegara et al. 2020).

f. Tiktok

TikTok, yang disebut Douyin di Tiongkok, merupakan wadah berbagi jejaring sosial yang menggunakan klip video singkat untuk merekam dan menyajikan berbagai bentuk kreativitas, pengetahuan, dan momen seperti tarian. Aplikasi ini diluncurkan di China dan kemudian pada tahun 2017 hadir dengan nama TikTok untuk pasar global

(Y. R. Dewi 2021). Menurut penelitian Firamadhina and Krisnani (2020), sebagian besar siswa berpendapat bahwa media sosial lebih sering digunakan oleh promotor produk dibandingkan oleh pendidik. Meskipun demikian, media sosial tetap diikuti oleh baik pendidik maupun siswa. Responden juga sepakat bahwa perubahan dalam sistem akademik diperlukan, serta media sosial dapat menjadi metode yang lebih inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan. (Firamadhina and Krisnani 2020).

C. Informasi terkait Keterpaparan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden, yaitu 783 orang (88,3%), terpapar informasi, sementara 104 orang (11,7%) tidak terpapar informasi. Masa remaja merupakan tahap pertumbuhan ketika tubuh menghadapi transformasi signifikan, termasuk kedewasaan seksual. Sayangnya, tidak seluruh pemuda memiliki pengetahuan memadai tentang transformasi biologis yang berlangsung pada tubuh mereka. Sebagai akibatnya, banyak pemuda terlibat dalam tindakan seksual berbahaya, seperti berciuman, berpelukan, menyentuh, atau merangsang, tanpa menyadari potensi risiko yang bisa muncul, termasuk penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan (Sukriani et al. 2022).

Informasi yang penting seringkali dapat diperoleh melalui media massa. Remaja cenderung memanfaatkan media massa untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai perilaku seksual. Semua jenis media, baik elektronik maupun cetak, menjadi faktor utama yang mempengaruhi penurunan moral remaja, karena akses yang mudah terhadap informasi negatif. Tayangan yang mengandung unsur pornografi, seperti gambar perempuan berpakaian minim di media cetak dan elektronik, cerita dengan konten seksual, adegan seks, video porno, dan sejenisnya, dapat dengan mudah ditemukan.

Media memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan pengetahuan, termasuk budaya barat ke Indonesia, seperti seks bebas, pakaian minim, dan perilaku menunjukkan fisik kepada lawan jenis, yang dapat meningkatkan keinginan seksual pada remaja. Selain itu, hotel, toko, dan restoran seringkali menjadi tempat yang mendukung remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Banyak juga tempat-tempat tersebut yang menjadi lokasi untuk kegiatan ilegal seperti prostitusi dan perdagangan narkoba. Penyebaran pornografi sangat beragam, misalnya melalui buku, koran, majalah, dan media cetak lainnya, sementara dalam media elektronik, pornografi dapat ditemukan melalui VCD, DVD, video, dan sebagainya. Tayangan film dengan konten seksual juga sering muncul di televisi (Istawati, 2017).

Bab 4

Kelahiran Pada Remaja

A. Remaja

Masa remaja adalah fase peralihan dari pubertas menuju kedewasaan, yang umumnya berlangsung antara usia 11 hingga 20 tahun. Pada periode ini, seseorang mulai membentuk identitas diri, meraih kemandirian dari keluarga, dan berusaha mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Selama fase ini, remaja mengalami perkembangan fisik yang signifikan dan kadang-kadang perubahan psikologis juga terjadi.

Masa remaja merupakan periode transisi yang dinamis, ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Berbagai lembaga di dunia memiliki definisi yang berbeda mengenai rentang usia remaja. WHO mendefinisikan remaja sebagai individu berusia 12-24 tahun yang sedang mengalami proses menuju kedewasaan. Di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan dan BKKBN memiliki rentang usia remaja yang sedikit berbeda, yaitu antara 10-18 tahun dan 10-24 tahun untuk yang belum menikah.

Sementara itu, di Amerika Serikat, remaja dikategorikan lebih rinci menjadi tiga fase berdasarkan karakteristik perkembangan mereka (Kusmiran, 2011). Remaja adalah kelompok usia yang unik, berada di antara dunia anak-anak dan dewasa. Menurut WHO, remaja adalah individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami tekanan sosial yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, membangun hubungan interpersonal, dan menemukan jati diri. Perubahan hormonal dan fisik yang terjadi juga turut mempengaruhi perkembangan psikologis remaja. Masa remaja adalah periode yang sangat penting untuk pembentukan perilaku kesehatan reproduksi, karena pada masa inilah remaja mulai membentuk kebiasaan dan sikap yang akan memengaruhi kesehatan mereka di masa depan. (Litbangkes 2015).

Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020-2030, di mana jumlah penduduk usia muda atau anak-anak akan semakin menurun, sementara jumlah penduduk usia produktif, termasuk remaja, akan sangat besar. Jika remaja dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas selama periode tersebut, bonus demografi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membawa potensi risiko tinggi terkait masalah remaja, seperti isu kesehatan reproduksi yang sering dimulai dengan pacaran dan seks bebas. Perubahan fisik dan seksual yang terjadi pada remaja meningkatkan ketertarikan

seksual terhadap lawan jenis serta dorongan seksual yang semakin kuat, yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan remaja, termasuk risiko terjadinya perilaku menyimpang yang berpotensi menyebabkan kehamilan pada remaja.

Gaya berpacaran remaja saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku seksual fisik, seperti berciuman, berpelukan, hingga berhubungan seks. Beberapa remaja bahkan sudah terlibat dalam hubungan seksual lebih dari satu kali (Amalia and Azinar 2017). Dalam (Girsang 2020) menyebutkan bahwa beberapa informan pernah terlibat dalam hubungan seksual pranikah dan melakukannya lebih dari sekali. Salah satu pendorong utama remaja untuk terlibat dalam perilaku seksual adalah rasa ingin tahu yang tinggi terhadap seksualitas. Dorongan alami untuk memahami tubuh dan hubungan antar manusia seringkali menjadi pemicu bagi remaja untuk mengeksplorasi aspek-aspek seksual (Aziza and Amperaningsih 2014). Perilaku seksual sering kali diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil yang tampak, sementara masalah yang lebih besar tersembunyi. Perilaku ini dapat mengarah pada kehamilan yang tidak direncanakan di kalangan remaja. Kehamilan yang tidak diinginkan sering dialami oleh perempuan muda yang baru memulai pengalaman seksual. Sebagian besar kehamilan pada remaja adalah KTD, yang terjadi sebelum pernikahan dan sering berakhir dengan tindakan aborsi (Isnaini and Sari 2019).

Setiap tahun, sekitar 15 juta remaja berusia 15-19 tahun di seluruh dunia melahirkan, dan 4 juta di antaranya melakukan aborsi (S, Laksono dan Rustiana, 2018). Menurut wawancara dengan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia cukup tinggi, mencapai 17,5%. Di beberapa daerah seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi, hampir semua remaja berusia 13 hingga 18 tahun telah kehilangan keperawanannya. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam hubungan seksual pranikah dan tidak sedikit yang hamil sebelum menikah (Realita dan Rahmawati, 2016). Laporan SDKI 2017 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun mengalami kehamilan tidak diinginkan dua kali lebih banyak (16%) dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Selain itu, fenomena ini dialami oleh 21% perempuan dan 10% laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu di bawah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan individu. Fenomena ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Menurut BKKBN (2017), sebaran kehamilan tidak diinginkan paling banyak terjadi di Kepulauan Bangka (29,9%), DKI Jakarta (26,0%), dan DI Yogyakarta (24,1%).

B. Tahap Perkembangan Pada Remaja

Menurut Sarwono (2011) dan Hurlock (2011) ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu:

1. Remaja awal (*early adolescence*) usia 11-13 tahun
Seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan- perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Pada tahap ini remaja awal sulit untuk mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Remaja ingin bebas dan mulai berfikir abstrak.
2. Remaja Madya (*middle adolescence*) 14-16 tahun
Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama pada dirinya. Remaja cenderung berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Pada fase remaja madya ini mulai timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal tentang aktivitas seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas-aktivitas seksual yang mereka inginkan.
3. Remaja akhir (*late adolescence*) 17-19 tahun
Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu:
 - a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
 - b. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru.

- c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri).
- e. Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan publik.

C. Perkembangan Fisik Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Bahkan perubahan- perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja (Sarwono, 2010).

Diantara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan menjadi makin panjang dan tinggi), mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki) dan tanda-tanda seksual yang tumbuh.

Secara lengkap urutan perubahan-perubahan fisik tersebut sebagai berikut:

1. Pada anak perempuan
 - a. Pertumbuhan tulang-tulang (badan menjadi tinggi, anggota- anggota badan menjadi panjang).
 - b. Pertumbuhan payudara.
 - c. Tumbuh bulu yang halus dan lurus berwarna gelap di kemaluan.

- d. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya.
 - e. Bulu kemaluan menjadi keriting.
 - f. Haid.
 - g. Tumbuh bulu-bulu ketiak.
2. Pada anak laki-laki
- a. Pertumbuhan tulang-tulang.
 - b. Testis (buah pelir) membesar.
 - c. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap.
 - d. Awal perubahan suara.
 - e. Ejakulasi (keluarnya air mani).
 - f. Bulu kemaluan menjadi keriting.
 - g. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya.
 - h. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah (kumis, jenggot).
 - i. Tumbuh bulu ketiak.
 - j. Akhir perubahan suara.
 - k. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap.
 - l. Tumbuh bulu di dada.

Perubahan-perubahan fisik itu, menyebabkan kecanggungan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya itu. Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat, membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula

dalam menghadapi haid dan ejakulasi yang pertama, remaja perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak selalu bisa dilakukannya dengan mulus, terutama jika tidak ada dukungan dari orang tua (Sarwono, 2010).

D. Perkembangan Psikologis Remaja

Secara psikologik kedewasaan tentu bukan hanya tercapainya umur tertentu seperti misalnya dalam ilmu hukum. Secara psikologik kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologik tertentu pada seseorang.

Ciri-ciri psikologik (Sarwono, 2010) itu adalah

1. Pemekaran diri sendiri (Extension of the self), yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egois (mementingkan diri sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya. Ciri lain adalah berkembangnya ego ideal berupa cita-cita, idola dan sebagainya yang menggambarkan bagaimana wujud ego (diri sendiri) di masa depan.
2. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan untuk menangkap humor termasuk yang menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran.

E. Seksualitas Pada Remaja

Seksualitas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jenis kelamin. Seksualitas mencakup beberapa dimensi yang sangat luas, antara lain dimensi biologis, sosio-psikologis, dan budaya. Berdasarkan dimensi biologis (fisik), seksualitas berkaitan dengan anatomi dan fungsi alat kelamin serta dampaknya terhadap kehidupan fisik, termasuk dinamika munculnya hasrat seksual biologis. masyarakat melakukan aktivitas seksual dengan mempertimbangkan identitas seksual dan aspek psikologisnya (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dimensi sosial mengkaji bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan interpersonal, bagaimana seseorang menyesuaikan diri atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran lingkungan sosial, dan bagaimana peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan seseorang disosialisasikan. (Sebayang, Sidabutar, & Gultom, 2018).

Di sisi lain, definisi seksualitas menurut Freud dalam psikoanalisis mempunyai makna yang luas. Seksualitas tidak hanya mencakup hubungan alat kelamin di masa dewasa, tetapi juga semua tindakan seperti menyusui, menghisap, buang air kecil, dan makan. Perilaku seksual seperti ini sudah ada sejak kecil (Kwirinus, 2022).

Seksualitas remaja merujuk kepada perasaan seksual, perilaku dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusia. Seksualitas sering merupakan aspek penting dari kehidupan remaja. Seksualitas remaja

merujuk kepada perasaan seksual, perilaku dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusia (Zastrow dan Kirst-Ashman, 2012). Seksualitas sering merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan remaja. Perilaku seksual remaja adalah, pada banyak kasus, dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat, orientasi seksual mereka, dan isu-isu control sosial, seperti hukum umur dewasa (Zastrow and Kirst-Ashman, K 2012).

Menurut Sigmund Freud ada lima tahap perkembangan psikoseksual yaitu:

1. Yang pertama fase oral (0-2 tahun),
Masa oral merupakan tahap awal dalam kehidupan manusia saat bayi berkomunikasi dengan ibunya melalui pemberian ASI. Kehidupan. seorang anak bergantung pada ibunya. Bayi pertama kali mengasosiasikan dirinya dengan kepuasan menghisap dan menelan. Area mulut merupakan tempat utama aktivitas, atau pusat kepuasan seksual, yang dipilih berdasarkan hasrat seksual. Mulut merupakan zona sensitif seksual yang bertugas memuaskan rasa puas bayi. Biasanya. bayi mendapat kepuasan tersebut dari menghisap payudara ibunya, namun selain menghisap payudara ibunya, terkadang juga menghisap jarinya sendiri.
2. Tahap anal (2-3 tahun)
Adalah tahap kedua, dan Freud percaya bahwa fokus utama kesenangan adalah pada pengendalian saluran

kemih dan buang air besar. Dubur adalah area kunci dari aktivitas pendudukan dinamis dan aktivitas kontra-pekerjaan yang berfokus pada fungsi ekskresi (pembuangan) Konflik utama pada tahap ini adalah toilet training, dimana anak belajar mengendalikan buang air besarnya.

3. Ketiga, Fase Falik (Fase Phallic) usia 3-5 tahun
Fase ini berfokus pada alat kelamin. Perkembangan utama dalam masa ini adalah adanya oedipus complex terjadi secara bersamaan dengan castration anxiety (pada laki-laki) dan penis envy (pada perempuan). Oedipus kompleks merupakan tidak di temukan objek seksual pada orang tua yang berbeda jenis serta pertikaian terhadap orang tua dengan jenis kelamin sama. Contoh seorang anak laki-laki ingin bersana ibunya terus dan ingin menyingkirkan ayahnya sebaliknya anak perempuan ingin memilih dekat dengan ayahnya merasa disaingin oleh kehadiran ibu dalam mendapatkan perhatian ayahnya.
4. Keempat yaitu Fase Laten (5-7 tahun)
Dimana pada masa di tandai dengan dorongan. nafsu yang emosional biasanya mempunyai pemahan yang cukup efektif. Dorongan. nafsu pada saat ini seolah "tidur" dan akan bangun dengan kekuatan penuh nanti di masa pubertas tahap terakhir.
5. Tahap genital yang merupakan tahap perkembangan terakhir psikoseksual Tahap genital terjadi sekitar usia 12 tahun hingga dewasa, ketika dorongan. seksual yang

ditekan pada tahap awal seperti tahap oral, anal, phallic, dan laten muncul kembali dan akibat dari semua ini mempengaruhi tahap ini. Pada tahap ini juga, seseorang mengembangkan ketertarikan seksual yang kuat terhadap lawan jenisnya. Dalam perkembangan ini, seseorang mengalami perubahan yang sangat penting pada dirinya dan dunianya. Tinggi dan berat badannya meningkat pesat. Ciri-ciri seksual primer dan sekunder mulai bermunculan. Hawa nafsu meningkat pesat pada tahap ini, pada tahap ini alat kelamin anak sudah matang dan anak mulai merasa tertarik dengan lawan jenisnya serta ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan orang lain. Artinya, orang mendapatkan kepuasan dengan menstimulasi dan memanipulasi tubuhnya (Hasanah, Fithriyah, & Mufrihah, 2021).

Zastrow and Kirst-Ashman, K (2012) berpendapat bahwa secara psikologis pada fase remaja ada dua aspek penting yang dipersiapkan, antara lain:

1. Orientasi seksual. Pada masa ini remaja diharapkan sudah menemukan orientasi seksualitasnya atau arah ketertarikan seksualnya (heteroseksualitas atau homoseksualitas). Norma umum yang berlaku lebih menyukai jika seseorang menyukai orientasi seksualitas ke arah heteroseksualitas. Namun, tidak dipungkiri ada remaja yang memilih orientasi seksualitas homoseksualitas. Orientasi ini dipengaruhi oleh penghayatan terhadap jenis kelamin. Faktor individu

(fisik atau psikologis), keluarga dan lingkungan ikut mendorong dan berperan dalam menguatkan identitas ini.

2. Peran seks. Peran seks adalah menerima dan mengembangkan peran serta kemampuan tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Laki-laki akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana laki-laki, demikian pula perempuan akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana perempuan. Peran seks ini sangat penting pada tahap pembentukan identitas diri, apakah seseorang itu berhasil mengidentifikasi dirinya atau justru melakukan transfer pada identitas yang lain

F. Pernikahan Pada Remaja (Pernikahan Dini)

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia yang ditetapkan oleh hukum, merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tradisi, tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan kehamilan di luar nikah seringkali menjadi alasan utama mengapa banyak remaja memutuskan untuk menikah di usia dini. Meskipun demikian, pernikahan dini membawa konsekuensi yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Remaja yang menikah dini seringkali belum siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan membesarkan anak.

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, terutama pada kelompok usia 10-19 tahun, merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab.

Faktor-faktor tersebut meliputi kemiskinan, kurangnya pendidikan, norma sosial yang membenarkan pernikahan dini, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan remaja. (Gunawan 2010).

G. Kehamilan Pada Usia Remaja

Aktivitas seksual yang dimulai lebih awal pada masa remaja membawa konsekuensi langsung yang tidak diinginkan, seperti peningkatan kasus penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang sering kali tidak direncanakan, yang dapat berujung pada aborsi. Hal ini juga berpotensi menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin (Futerman, Chabon, and Hoffman 2000).

Kehamilan pada remaja, yakni perempuan berusia antara 14 hingga 20 tahun, baik yang sudah menikah maupun belum, merupakan kondisi yang sangat berisiko. Risiko kematian ibu dan bayi pada remaja hamil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dewasa. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya organ reproduksi remaja, yang membuat mereka lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan seperti perdarahan hebat. Selain itu, risiko kematian bayi pada ibu hamil usia remaja juga dapat mencapai 30% lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20 hingga 30 tahun (Widyastuti, 2009).

Pernikahan usia muda terjadi seiring dengan tingginya persentase penduduk yang berada pada usia

remaja, yakni sekitar 26,7 persen dari total 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan definisi World Health Organization (WHO), usia remaja adalah antara 12 hingga 24 tahun. Di Indonesia, terdapat data yang menunjukkan bahwa sepertiga dari pernikahan terjadi pada pasangan yang berusia di bawah 16 tahun, bahkan di beberapa daerah pedesaan, pernikahan sering dilangsungkan segera setelah seorang gadis mengalami menstruasi pertama. Statistik menunjukkan bahwa 41,9 persen pernikahan terjadi pada usia 15 hingga 19 tahun, sementara 4,8 persen terjadi pada usia 10 hingga 14 tahun (Hapisah & Rizani, 2015).

Dari perspektif biologis, kehamilan pada usia remaja dapat menyebabkan peningkatan risiko gangguan hipertensi selama kehamilan, anemia, diabetes gestasional, serta komplikasi saat persalinan, yang pada akhirnya meningkatkan angka kematian ibu dan janin (D. V. de Azevedo and Sampaio 2003; Carvalho et al. 2006). Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya tren peningkatan kejadian masalah prenatal, intrapartum, dan postpartum di kalangan remaja yang hamil (Michelazzo et al. 2004; Iacobelli et al. 2012).

Perempuan yang hamil di usia remaja (14-20 tahun) seringkali belum siap secara fisik maupun psikologis untuk menjalani kehamilan. Menurut Permatasari (2012), organ reproduksi remaja yang belum sepenuhnya matang meningkatkan risiko terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, dari perspektif psikologis, remaja yang hamil seringkali belum siap

menghadapi tuntutan peran sebagai orang tua, sehingga dapat mengalami tekanan emosional dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan hidup yang signifikan (Rachmawati 2014).

H. Dampak Kehamilan Pada Remaja

Perkawinan dan kehamilan yang dilangsungkan pada usia muda (remaja) umumnya akan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Putus sekolah

Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja karena terpaksa meninggalkan sekolah. Cita-cita yang diimpikan akan terhambat atau bahkan mungkin tidak dapat tercapai. Selain itu, terdapat pula perlakuan yang kurang adil dari masyarakat atau institusi formal terhadap remaja perempuan. Sering kali dalam suatu kasus kehamilan di luar nikah yang tidak boleh melanjutkan sekolah adalah remaja perempuan. Sedangkan remaja laki-laki masih diperbolehkan melanjutkan sekolah. Pandangan negatif dari masyarakatpun cenderung lebih memberatkan perempuan dibandingkan laki-laki (Kusmiran, 2014).

2. Menurut Kumalasari (2012), dampak yang terjadi karena kehamilan tidak diinginkan oleh remaja berpengaruh pada:

- a. Kesehatan Perempuan

- 1) Alat reproduksi belum siap menerima

kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.

- 2) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
- 3) Risiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
- 4) Berisiko pada kematian usia dini.
- 5) Meningkatnya angka kematian ibu (AKI).
- 6) Risiko terkena penyakit menular seksual.

b. Kualitas Anak

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- 2) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata – rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5 – 30 kali lebih tinggi untuk meninggal.

I. Melahirkan Pada Usia Remaja

Kelahiran alami mengacu pada proses biologis keluarnya bayi melalui saluran lahir pada kehamilan matang, dengan posisi kepala terlebih dahulu dan tanpa hambatan. Tahapan ini biasanya terjadi dalam durasi 12-18 jam. Melahirkan merupakan momen penting dan puncak bagi setiap calon ibu. Mengingat betapa pentingnya persalinan, ibu biasanya memiliki harapan tertentu selama proses ini. Harapan-harapan tersebut meliputi kemampuan

mengatasi rasa sakit, mendapatkan dukungan dari suami, dukungan dari tenaga medis yang menangani persalinan, serta minimnya intervensi medis (Iravani et al, 2015).

Fertilitas, dalam ranah kependudukan, merujuk pada kapasitas reproduksi seorang perempuan yang dihitung berdasarkan jumlah anak yang lahir hidup. Aspek ini, selain perpindahan penduduk, sangat memengaruhi peningkatan populasi. Angka kelahiran pada masa lampau memberikan dampak besar terhadap tingkat fertilitas saat ini. (Adioetomo dan Samosir, 2011).

Ibu muda yang sedang berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan seringkali merasa tidak siap menghadapi persalinan. Tingginya angka kelahiran pada remaja membawa risiko besar terhadap komplikasi persalinan, bahkan kematian ibu. Situasi ini merupakan persoalan krusial yang perlu segera diselesaikan sebab dapat memberikan dampak buruk terhadap proses persalinan (Cavazos-Rehg et al., 2015).

Terkait dengan bayi baru lahir, kehamilan pada usia remaja sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus BBLR, kelahiran prematur, masalah pernapasan, serta cedera saat kelahiran. Selain itu, juga terdapat tingginya frekuensi komplikasi neonatal dan kematian bayi.

J. Dampak Melahirkan Pada Usia Remaja

Kehamilan pada remaja tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Remaja hamil seringkali menghadapi stigma sosial,

kesulitan melanjutkan pendidikan, dan keterbatasan dalam mengejar karier. Risiko kesehatan yang tinggi, seperti kanker serviks, juga menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi mereka di masa depan. Dari sisi psikologis, remaja yang terpaksa menikah dan hamil di usia muda sering kali tidak memiliki kesiapan mental untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Hal ini membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, karena posisi tawar mereka yang lemah. Selain itu, beban psikologis dari kehamilan dan pengasuhan anak pada usia yang masih muda dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut. Anak yang dilahirkan oleh ibu muda menghadapi potensi masalah kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu dewasa. Beberapa potensi masalah tersebut mencakup kelahiran prematur, di mana anak lahir sebelum usia kandungan 37 minggu, berat badan lahir rendah, dan berbagai kelainan bawaan. Selain itu, anak yang lahir dari ibu muda juga memiliki potensi kematian yang lebih tinggi hingga melampaui 50%. (Gennari 2013)

Kelahiran pada usia remaja dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi karena tubuh dan organ reproduksi yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga kehamilan dan persalinan di bawah usia 20 tahun membawa berbagai risiko. Risiko terhadap kesehatan fisik mencakup komplikasi kehamilan serta ancaman bagi janin, seperti anemia kehamilan yang berbahaya bagi ibu dan bayi. Selain itu, ibu hamil remaja berisiko mengalami

persalinan yang lama, perdarahan yang lebih banyak selama proses persalinan dan masa nifas, serta penurunan produksi ASI. Kehamilan pada perempuan muda tidak hanya berbahaya selama proses kehamilan itu sendiri, namun juga dapat menimbulkan masalah kesehatan dalam jangka panjang. Beberapa masalah yang bisa muncul antara lain hipertensi selama kehamilan, pendarahan setelah melahirkan, dan keguguran. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan reproduksi jangka panjang dan mutu hidup gadis muda tersebut. (Kemenkes, 2010).

Selain itu, melahirkan pada usia dini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kelahiran prematur, korioamionitis, endometritis, preeklamsia berat, eklamsia, perdarahan postpartum, hambatan pertumbuhan janin, gawat janin, dan bahkan kematian (Azevedo et al, 2015 dan Socolov et al, 2017). Komplikasi lain yang mungkin terjadi termasuk operasi caesar, infeksi saluran kemih, fistula kebidanan dan kandung kemih, atau perforasi usus akibat persalinan yang lama, serta peningkatan risiko kanker serviks (Najati & Gojazadeh, 2010).

Wanita remaja dan bayi mereka memiliki risiko lebih tinggi terhadap hasil kesehatan yang buruk, seperti fistula kebidanan, sepsis, kelahiran mati, kelahiran prematur, asfiksia lahir, rendahnya kelangsungan hidup anak, dan gangguan jiwa. Secara sosial, remaja perempuan sering menghadapi kekerasan dari keluarga dan masyarakat, serta diskriminasi dan stigma, yang dapat berujung pada kerugian ekonomi yang besar, ditambah dengan

kemungkinan putus sekolah dan pernikahan dini (Mollborn S, 2017).

K. Studi terkait Kelahiran Pada Remaja

Mayoritas responden melahirkan pada usia di atas 19 tahun, yaitu sebanyak 631 orang (71,1%), sementara 256 remaja (28,5%) melahirkan pada usia di bawah 19 tahun.

Masa muda adalah periode yang krusial dalam pertumbuhan fisik dan mental. Kehamilan pada usia muda dapat mengganggu proses perkembangan ini dan meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai masalah. Remaja yang hamil lebih rentan mengalami gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kekurangan darah, infeksi, dan kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan oleh remaja juga berisiko mengalami kelainan bawaan, berat badan lahir rendah, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kehamilan pada remaja juga dapat mempengaruhi kesehatan psikologis dan kesejahteraan sosial remaja (SM and Putri 2022).

Kelahiran prematur, khususnya pada remaja, memiliki efek yang besar terhadap kesehatan ibu dan anak. Data Risesdas 2018 mengungkapkan bahwa proporsi kelahiran prematur di Indonesia cukup signifikan, terutama di kalangan remaja. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai unsur, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Bayi prematur berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, masalah penglihatan, dan gangguan pertumbuhan (Purba dkk., 2016.)

Kehamilan pada usia remaja di bawah 20 tahun merupakan salah satu faktor risiko kelahiran bayi prematur dengan BBLR. Pada kehamilan remaja, perhatian sering kali terfokus pada pemenuhan nutrisi untuk pertumbuhan janin, yang bisa berkontribusi pada terjadinya BBLR. Usia ibu saat hamil memengaruhi kondisi kehamilan karena berhubungan dengan aspek psikologis dan kematangan reproduksi. Kekurangan gizi pada remaja hamil juga meningkatkan risiko kelahiran prematur dan BBLR (Siregar dkk., 2020). Selama masa kehamilan, baik pertumbuhan fisik remaja maupun janin dapat terganggu. Nutrisi yang tidak mencukupi selama kehamilan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah serta komplikasi selama kehamilan dan persalinan, karena remaja masih membutuhkan asupan gizi untuk pertumbuhan fisiknya, yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ibu dan janin (Hadiwijaya & Kumala, 2019).

Komplikasi persalinan pada kehamilan remaja selain kelahiran prematur bisa berupa persalinan melalui SC, KPD, persalinan yang dibantu alat, dan juga persalinan lama. Namun, persalinan dengan SC dan bantuan alat cenderung lebih jarang terjadi pada kehamilan remaja, karena kehamilan pada usia ini lebih sering mengarah pada kelahiran prematur dengan BBLR (Sembiring, Pratiwi, and Sarumaha 2019). Ketidakmatangan serviks dan selaput ketuban pada remaja hamil meningkatkan risiko terjadinya KPD. Kondisi ini dapat memicu komplikasi kehamilan,

seperti kelahiran prematur dan infeksi pada ibu dan bayi (W. F. de Azevedo et al. 2015).

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan kunci dalam mencegah kehamilan remaja dan komplikasi yang terkait. Dengan memberikan informasi yang akurat dan up-to-date tentang kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan mereka. Edukasi juga perlu melibatkan keluarga, agar mereka dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada remaja.

Selain itu, kehamilan pada usia remaja dapat berdampak pada bayi, seperti kelahiran bayi dengan BBLR, komplikasi intrapartum, kelahiran prematur, dan cacat lahir, yang dapat menjadi penyebab kematian neonatal. Hal ini juga berisiko bagi bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun.

Ini selaras dengan kajian (Mahendra 2017) memperlihatkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi kelahiran pada remaja antara lain indeks kekayaan, paparan media, dan interaksi dengan petugas keluarga berencana. Kemiskinan dapat membatasi kekuasaan remaja perempuan dalam mengambil keputusan tentang kelahiran berikutnya dan juga menyebabkan rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (Aslam RW et al, 2017).

Bab 5

Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi dan Keterpaparan Informasi Terhadap Kelahiran Remaja

A. Penggunaan Kontrasepsi Terhadap Kelahiran Remaja

Temuan kajian memperlihatkan bahwa mayoritas remaja yang melahirkan setelah usia 19 tahun menggunakan alat kontrasepsi, dengan jumlah 456 orang (51,4%), sementara di antara remaja yang melahirkan pada usia ≤ 19 tahun, hanya 140 orang (15,8%) yang menggunakan alat kontrasepsi. Dengan angka $p = 0,00$, yang jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang sangat signifikan secara statistik antara pemakaian alat kontrasepsi dan insiden kelahiran remaja di Provinsi NTB. Temuan ini menunjukkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi efektif dalam menurunkan angka kelahiran remaja di daerah tersebut.

Kehamilan pada remaja merupakan masalah multifaktorial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari individu hingga lingkungan sosial. Perilaku seksual berisiko, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan akses yang terbatas terhadap layanan kontrasepsi merupakan beberapa faktor utama. Selain itu, faktor sosial seperti dukungan keluarga, norma budaya, dan status sosial ekonomi juga berperan penting dalam mencegah atau mendorong terjadinya kehamilan pada remaja (Ramadani, Nursal, and Ramli 2015).

Kehamilan pada usia remaja bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Remaja yang hamil cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan peluang ekonomi yang terbatas. Hal ini dapat memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Secara global, kelahiran pada usia remaja akan mempercepat laju pertumbuhan penduduk dan memperpanjang masa reproduksi, yang berpotensi meningkatkan tingkat fertilitas (Raharja 2014).

Ketidaksuburan atau infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor medis. Gangguan pada sistem reproduksi wanita, seperti kelainan pada indung telur, endometriosis, atau masalah pada saluran tuba, dapat menghambat proses pembuahan. Pada pria, gangguan produksi sperma atau masalah pada saluran reproduksi dapat menjadi penyebab. Selain itu, penggunaan kontrasepsi juga dapat memengaruhi kesuburan, meskipun efeknya bersifat sementara dan dapat pulih setelah

penghentian penggunaan. Faktor-faktor yang disengaja, seperti sterilisasi, penggunaan IUD, suntik KB, atau obat-obatan juga turut berperan dalam kesuburan atau kemandulan.

Penggunaan alat kontrasepsi dapat mencegah kehamilan pada remaja, karena alat kontrasepsi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kehamilan atau kelahiran di usia muda. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi di kalangan remaja meliputi kebijakan yang mewajibkan penggunaan kontrasepsi, membangun dukungan masyarakat untuk penyediaan kontrasepsi bagi remaja, memberikan pendidikan tentang seksualitas baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah, serta meningkatkan akses dan penggunaan kontrasepsi dengan menyediakan layanan kesehatan yang ramah remaja. Selain itu, mengintegrasikan layanan kontrasepsi dengan layanan kesehatan lainnya dan menyediakan kontrasepsi melalui berbagai saluran juga dapat mendukung hal tersebut. Pemanfaatan ponsel dan media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi di kalangan remaja (Chandra-Mouli et al, 2020).

Angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Hasil survei menunjukkan bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 150.000 hingga 200.000 kasus KTD di Indonesia. Lebih lanjut, sebuah survei di sembilan kota besar mencatat bahwa sekitar 27% dari kasus KTD terjadi di luar pernikahan

dan melibatkan pelajar. Data ini menunjukkan tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan pada kelompok usia remaja (Wahyudi, 2010). Dampak dari KTD bisa berupa aborsi, yang jika dilakukan secara tidak aman dapat berujung pada kematian ibu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap KTD, terutama pada remaja putri yang aktif secara seksual, karena mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami KTD. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi, seperti pil, kondom, dan suntikan, serta memberikan edukasi mengenai cara penggunaannya (Mardiyah 2019).

B. Pengaruh Keterpaparan Informasi Terhadap Kelahiran Remaja

Berdasarkan hasil, mayoritas responden yang melahirkan pada usia lebih dari 19 tahun sebanyak 571 orang (64,6%) terpapar informasi tentang kesehatan reproduksi, sedangkan 212 responden (23,9%) yang melahirkan pada usia 19 tahun atau lebih muda juga terpapar informasi tersebut. Dengan nilai $p\text{-value} = 0,00$ dan $\alpha = 0,05$, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterpaparan informasi mengenai kesehatan reproduksi dengan kelahiran pada usia remaja di Provinsi NTB.

Pemberian informasi dan edukasi yang benar mengenai seksualitas dapat membantu mencegah remaja terlibat dalam hubungan seksual pranikah (A W Pinandari

2015). Sayangnya, tidak semua informasi yang didapat remaja dari media bersifat positif. Konten negatif, termasuk pornografi, justru dapat memicu ketertarikan remaja pada seks pranikah (A. P. Dewi 2012). Paparan terus-menerus terhadap konten seksual yang tidak sehat melalui media dapat meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko pada remaja. Sayangnya, di banyak negara, media masih kurang memberikan edukasi seks yang komprehensif dan bertanggung jawab (Puspasari and Emilia 2017).

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Yanti et al. (2018). Studi tersebut menunjukkan bahwa media massa dan elektronik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan remaja untuk menikah dini. Faktor-faktor seperti kehamilan yang tidak direncanakan, lingkungan sosial, dan pendidikan juga berperan penting, namun pengaruh media tidak dapat diabaikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Henni Febriawati (2019) menunjukkan bahwa keterpaparan atau ketidak-terpaparan pada media informasi tidak memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan dini.

Media komunikasi massa, baik tertulis maupun digital, memegang peranan krusial dalam memengaruhi tindakan seksual remaja. Materi cabul dan informasi seksual yang keliru yang kerap dijumpai di media dapat mendorong tindakan seksual berbahaya pada remaja. Ini sejalan dengan remaja cenderung mencontoh perilaku yang mereka saksikan di media (Hotnatalia Naibaho, 2017).

Bab 6

Penutup

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Menurut KUHPdata Pasal 29, laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya 15 tahun. Akan tetapi, B.W. menetapkan batas usia dewasa yang lebih tinggi, yakni 21 tahun. Perbedaan persepsi ini memiliki dampak hukum yang penting, khususnya berkaitan dengan hak serta tanggung jawab individu yang masih di bawah usia.

Pernikahan anak merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang semakin rumit oleh faktor tradisi dan budaya dalam masyarakat. Stigma sosial terhadap pernikahan yang terjadi setelah masa pubertas, yang dianggap sebagai aib dalam beberapa kelompok, turut meningkatkan angka pernikahan dini. Faktor ekonomi, harapan akan keamanan sosial dan finansial setelah menikah, juga mendorong banyak orang tua untuk menyetujui pernikahan usia dini. Namun, kenyataannya, pernikahan dini membawa dampak negatif yang mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial para pelakunya. Dampak tersebut tidak jarang berlawanan

dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu kebahagiaan, malah membawa kemudaratn bahkan kesengsaraan.

Pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor individu, sosial, dan budaya. Menurut Sarwono (2003), remaja sering kali menikah dini karena tekanan sosial, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas, dan pengaruh media. Faktor-faktor seperti kematangan emosional yang belum sempurna, rasa ingin tahu yang tinggi, dan tekanan teman sebaya juga turut berperan. Dalam kasus seperti ini, keluarga sering kali mengambil keputusan untuk menikahkan pasangan remaja tersebut. Penggunaan kontrasepsi diharapkan dapat menunda kehamilan dan kelahiran pada remaja.

Daftar Pustaka

- Afriani, Riska. 2016. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta." In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.
- Ahiyanasari, Citra Ervina, and Ira Nurmala. 2017. "Niatan Siswi SMA Untuk Mencegah Seks Pranikah." *Jurnal Promkes* 5(1): 39.
- Amalia, Elisa Happy, and Muhammad Azinar. 2017. "Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 1(1): 1–7.
- Amongin, Dinah et al. 2020. "Time Trends in and Factors Associated with Repeat Adolescent Birth in Uganda: Analysis of Six Demographic and Health Surveys." *PLoS One* 15(4): e0231557.
- Aslam, Rabeeah W et al. 2017. "Intervention Now to Eliminate Repeat Unintended Pregnancy in Teenagers (INTERUPT): A Systematic Review of Intervention Effectiveness and Cost-Effectiveness, and Qualitative and Realist Synthesis of Implementation Factors and User Engagement." *BMC medicine* 15: 1–13.
- Azevedo, Daniela Vasconcelos de, and Helena Alves de Carvalho Sampaio. 2003. "Fatores de Risco Associados à Gestação Na Adolescência." *Femina*: 457–63.
- Azevedo, Walter Fernandes de et al. 2015. "Complications in Adolescent Pregnancy: Systematic Review of the Literature." *Einstein (Sao Paulo)* 13(4): 618–26.
- Aziza, Nyimas, and Yuliati Amperaningsih. 2014. "Determinan Kehamilan Pada Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Natar Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik* 10(1): 143–53.
- Carvalho, Regina Coeli Marques de, Henry de Holanda Campos, Zenilda Vieira Bruno, and Rosa Maria Salani Mota. 2006.

"Fatores Preditivos de Hipertensão Gestacional Em Adolescentes Primíparas: Análise Do Pré-Natal, Da MAPA e Da Microalbuminúria." *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* 87: 487–95.

Chepkoech, Janet, Marie Khanyanji Khayesi, and James Onyango Ogola. 2019. "Sources of Information on Reproductive Health among Teenage Girls in Kaptembwo, Nakuru County, Kenya." *Int J Libr Sci* 8(1): 18–25.

Dewi, Ari P. 2012. "Hubungan Karakteristik Remaja, Peran Teman Sebaya Dan Paparan Pornografi Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Depok." *Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia*.

Dewi, Cici Guspa, and Yulidar Ibrahim. 2019. "Hubungan Self-Esteem (Harga Diri) Dengan Perilaku Narsisme Pengguna Media Sosial Instagram Pada Siswa SMA." *Jurnal Neo Konseling* 1(2).

Dewi, Yana Respati. 2021. "Creating Customer Engagement and Customer Value within 15 Second: How Tiktok Works for Content Marketing." *AMAR (Andalas Management Review)* 5(1): 33–45.

Donaldson, Abigail A, Laura D Lindberg, Jonathan M Ellen, and Arik V Marcell. 2013. "Receipt of Sexual Health Information from Parents, Teachers, and Healthcare Providers by Sexually Experienced US Adolescents." *Journal of Adolescent Health* 53(2): 235–40.

e Silva, João Luiz Pinto, and Fernanda Garanhani Surita. 2017. "Pregnancy in Adolescence-a Challenge beyond Public Health Policies." *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and Obstetrics* 39(02): 41–43.

Everett, Suzanne. 2020. *Handbook of Contraception and Sexual Health*. Routledge.

Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda, and Hetty Krisnani. 2020. "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial

- TikTok: TikTok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme." *Share Social Work Journal* 10(2): 199–208.
- Futterman, Donna, Brenda Chabon, and Neal D Hoffman. 2000. "HIV and AIDS in Adolescents." *Pediatric Clinics of North America* 47(1): 171–88.
- Gennari, Pamela J. 2013. "Adolescent Pregnancy in Developing Countries." *International Journal of Childbirth Education* 28(1).
- Girsang, Lesterina. 2020. "Studi Kualitatif Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja Di Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun." *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat* 2(2): 34–46.
- Gunawan, Agung N. 2010. "Pengaruh Kehamilan Di Usia Muda Terhadap Kelahiran Prematur." *Bul Penelitian RSUD Dr Soetomo* 12(4): 161–65.
- Hartanto, Hanafi. 2004. "Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi." *Jakarta: Pustaka sinar harapan* 37.
- Iacobelli, Silvia et al. 2012. "Obstetric and Neonatal Outcomes of Adolescent Primiparous Singleton Pregnancies: A Cohort Study in the South of Reunion Island, Indian Ocean." *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine* 25(12): 2591–96.
- Isnaini, Nurul, and Ratna Sari. 2019. "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 5(1).
- Istawati, Rika. 2017. "Hubungan Keterpaparan Media Massa, Peran Teman Sebaya Terhadap Tindakan Seksual Di Sma an-Naas." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2(2): 124–31.
- Kemenkes, R I. 2012. "Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia." *Jakarta: Kemenkes RI*.

- Kertanegara, M Rizky et al. 2020. "Pengaruh Tingkat Literasi Media Terhadap Perilaku Penyebaran Hoax Di Kalangan Generasi z (Studi Pada Siswa SMA Negeri 4 Depok)." *Konvergensi: jurnal ilmiah ilmu komunikasi* 2(1): 108–26.
- Korenčan, Simona, Bojana Pinter, Mojca Grebenc, and Ivan Verdenik. 2017. "The Outcomes of Pregnancy and Childbirth in Adolescents in Slovenia." *Slovenian Journal of Public Health* 56(4): 268–75.
- Litbangkes, Kemenkes R I. 2015. "Perilaku Beresiko Kesehatan Pada Pelajar SMP Dan SMA Di Indonesia." *Hasil Survey Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah di Indonesia*. Jakarta.
- Van Looy, Amy. 2016. "Social Media Management." *Advanced Database Marketing: Innovative Methodologies and Applications for Managing Customer Relationships*. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-21990-5>.
- Mahendra, A. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 223–42.
- Maravilla, Joemer C, Kim S Betts, and Rosa Alati. 2019. "Increased Risk of Maternal Complications from Repeat Pregnancy among Adolescent Women." *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 145(1): 54–61.
- Mardiyah, W D. 2019. "Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Remaja Putri Yang Aktif Seksual Di Wilayah Kerja Poskesdes Kerembong Lombok Tengah."
- Matahari, Ratu et al. 2019. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Pustaka Ilmu.
- Michelazzo, Daniela et al. 2004. "Indicadores Sociais de Grávidas Adolescentes: Estudo Caso-Controlle." *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia* 26: 633–39.
- Monika, Aprilia, Bintang Agustina Pratiwi, Henni Febriawati, and Nopia Wati. 2021. "Pengaruh Promosi Kesehatan Dengan

Metode Video Terhadap Pengetahuan Siswa Siswi Kelas XI Tentang Seksualitas Remaja Di SMAN 07 Kota Bengkulu." *Jurnal Miracle* 1(1): 47–54.

- Nabila, Luzia, and Ida Nikmatul Ulfa. 2015. "GAMBARAN KEJADIAN EFEK SAMPING PADA AKSEPTOR KB SUNTIK 1 BULAN DI DESA DENANYAR KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG: The Description of Genesis Side Effects In Acceptor KB Inject 1 Month in Denanyar Village Jombang." *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)* 1(1): 51–57.
- Nasrullah, Rulli. 2017. "Blogger Dan Digital Word of Mouth: Getok Tular Digital Ala Blogger Dalam Komunikasi Pemasaran Di Media Sosial." *Jurnal Sosioteknologi* 16(1): 1–16.
- Nurmayani, Winda, Ilham Ilham, Misroh Mulianingsih, and Baiq Handayani. 2024. "KETERPAPARAN DAN SUMBER INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL REMAJA (SKAP NTB 2019): EXPOSURE AND SOURCES OF REPRODUCTIVE HEALTH INFORMATION ON ADOLESCENT SEXUAL BEHAVIOR (SKAP NTB 2019)." *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 8(1).
- Permatasari, Ariesta. 2012. "Hubungan Antara Pengetahuan Faktor Risiko Kehamilan Dan Jenis Persalinan Di Rsud Dr. Moewardi."
- Pinandari, A W. 2015. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Formal Sebagai Pencegahan Perilaku Hubungan Seksual Pranikah Remaja Dan Dewasa Muda Di Indonesia(Analisis Data SDKI 2012). Ilmu Kesehatan Masyarakat." *Universitas Gajah Mada*.
- Pinandari, Anggriyani Wahyu, Siswanto Agus Wilopo, and Djauhar Ismail. 2015. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Formal Dan Hubungan Seksual Pranikah Remaja Indonesia." *Kesmas* 10(1): 44–50.
- Puspasari, Sukamdi, and Ova Emilia. 2017. "Paparan Informasi Kesehatan Reproduksi Melalui Media Pada Perilaku Seksual Pranikah: Analisis Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012." *Berita Kedokteran Masyarakat* 33(1): 31–36.

- Putri, Lidia Aditama. 2020. "Perbedaan Pemulihan Tingkat Kesuburan Pada Wanita Dengan Riwayat Kontrasepsi Suntik 1 Bulan Dan Suntik 3 Bulan Di BPM Meiyuni Kota Bangkalan." *WARTA BHAKTI HUSADA MULIA: Jurnal Kesehatan* 7(1).
- Putri, Lidia Aditama, and Nurun Nikmah. 2021. "Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dan Kejadian Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Pada Wanita Usia Subur." *IJMT: Indonesian Journal of Midwifery Today* 1(1): 9.
- Rachmawati, Jelia Karlina. 2014. "Penerimaan Diri Remaja Hamil Pra Nikah: Studi Kasus Pada 2 Remaja Hamil Pra Nikah Di Kota Bandung."
- Raharja, Mugia Bayu. 2014. "Fertilitas Remaja Di Indonesia." *Kesmas* 9(1): 6–13.
- Ramadani, Mery, Dien Gusta Anggraini Nursal, and Livia Ramli. 2015. "Peran Tenaga Kesehatan Dan Keluarga Dalam Kehamilan Usia Remaja." *Kesmas* 10(2): 87–92.
- Rosenberg, Hans, Shahbaz Syed, and Salim Rezaie. 2020. "The Twitter Pandemic: The Critical Role of Twitter in the Dissemination of Medical Information and Misinformation during the COVID-19 Pandemic." *Canadian journal of emergency medicine* 22(4): 418–21.
- Rusmini, Purwandi S, V N Utami, and S N Fauziah. 2017. "Pelayanan KB Dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: CV." *Trans Info Media*.
- Saha, Ria, Pintu Paul, Sanni Yaya, and Aduragbemi Banke-Thomas. 2022. "Association between Exposure to Social Media and Knowledge of Sexual and Reproductive Health among Adolescent Girls: Evidence from the UDAYA Survey in Bihar and Uttar Pradesh, India." *Reproductive health* 19(1): 178.
- Sembiring, Julina B R, Debby Pratiwi, and Aprilian Sarumaha. 2019. "Hubungan Usia, Paritas Dan Usia Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah Di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan." *Jurnal Bidan Komunitas* 2(1): 38–46.

- Setiawati, Maria Caecilia Nanny, Erna Prasetyaningrum, and Desah Alit. 2020. "Efek Samping Pil KB Pada Akseptor Di Kelurahan Manyaran Kota Semarang." *Cendekia Journal of Pharmacy* 4(2): 175–84.
- Sinaga, Lennaria, Hardiani Hardiani, and Purwaka Hari Prihanto. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas Di Perdesaan (Studi Pada Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12(1): 41–48.
- SM, Sefryani Nursari, and Putri Putri. 2022. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kehamilan Usia Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Pandan." *Journal Of Healthcare Technology And Medicine* 8(1): 100–110.
- Sukriani, Wahidah et al. 2022. "Keterpaparan Informasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengalaman Seksual Remaja." *Window of Health: Jurnal Kesehatan*. 723–34.
- WHO. 2018. *Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health*. World healt Organization.
- . 2020. *Adolescent Pregnancy. Fact Sheet*. World healt Organization.
- Wiknjosastro, Hanifa. 2007. "Ilmu Kebidanan." *Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo* 180(240): 653.

Glosarium

A

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu

B

Bifasik: Pil mengandung hormone ktif estrogen/progestin dalam dua dosis yang berbeda

E

Endometritis: Adalah Kondisi peradangan pada lapisan rahim (endometrium) yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Kondisi ini dapat menyerang wanita dengan faktor risiko tertentu.

F

Fertilitas: Adalah fertilitas didefinisikan sebagai peristiwa melahirkan anak lahir hidup dari seorang perempuan. Istilah ini sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan

Flour Albus: adalah keluarnya cairan bening atau putih dari vagina, yang sebagian besar terdiri dari sel dan bakteri.

I

Intrapartum: Adalah periode waktu yang mencakup persalinan, yaitu mulai dari awal persalinan hingga keluarnya plasenta

K

Ketuban pecah dini (KPD) adalah kondisi ketika kantung ketuban pecah sebelum persalinan dimulai

Kuadrifasik: Adalah Pil mengandung hormon aktif estrogen/progestin dalam empat dosis yang berbeda.

Korioamionitis: Adalah nflamasi dan/atau infeksi pada membran amniotik dan membran korionik, serta jaringan yang terkait, seperti desidua, pembuluh darah fetal, dan korda umbilikal

M

Morbiditas: angka kesakitan merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk suatu Negara.

Mortalitas: adalah angka kematian atau tingkat kematian dalam suatu populasi atau kelompok dalam periode waktu tertentu

Monofasik: Adalah Pil mengandung hormone aktif estrogen/progestin dalam dosis yang sama.

P

Premature: Adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya leher rahim (serviks) sehingga membuat janin memasuki jalan lahir.

Pubertas: Adalah tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10–14 tahun. Sementara itu, pubertas pada laki-laki terjadi pada kisaran usia 12–16 tahun

Pornografi: Adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Pornoaksi: adalah sikap, perilaku, gerakan tubuh, dan suara yang erotis dan sensual, baik dilakukan secara sendirian atau bersama-sama. Pornoaksi merupakan bagian dari pornografi, yang sama-sama menciptakan unsur-unsur yang bersifat porno.

S

Sex Pranikah: Adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja tanpa adanya ikatan pernikahan.

Stenosis canalis cervicalis: Adalah penyempitan abnormal pada kanal tulang belakang di bagian leher yang membahayakan sumsum tulang belakang dan akar saraf.

Spermatogenesis: adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di testis pria.

T

Trifasik: Adalah Pil mengandung hormone aktif estrogen/progestin dalam tiga dosis yang berbeda Jenis pil trifasik yang beredar dipasaran.

Profil Penulis



Winda Nurmayani M., S.Kep., Ners., MPH.

Lahir di Praya 1 Juli 1981. Lulus D3 Keperawatan tahun 2003 di Poltekes Kemenkes Mataram, Melanjutkan pendidikan S1 keperawatan di Stikes Muhammadiyah Gombong dan lulus tahun 2007, menyelesaikan pendidikan Profesi Ners tahun 2008, dan Program Pasca Sarjana tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada. Diangkat sebagai

Dosen Di Stikes Yarsi Mataram pada tahun 2004 dan sampai sekarang masih aktif sebagai dosen di Inkes Yarsi Mataram yang sudah terjadi perubahan status. Mata Kuliah yg diampunya antara lain: Keperawatan Maternitas 1&2, Sistem Reproduksi, Ilmu keperawatan Dasar, Konsep dasar Keperawatan dan Promosi kesehatan. Aktif dalam organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Email Penulis: nurmayani.winda81@gmail.com

Profil Penulis



Ilham, S. Kep., Ners., M. Kep.

Penulis tertarik terhadap ilmu keperawatan dimulai pada tahun 2006, sehingga penulis memutuskan untuk menempuh Pendidikan tinggi dimulai dari S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKES YARSI Mataram dan lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan Profesi Ners di institusi yang sama dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada, Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan berhasil lulus tahun 2016. Penulis memiliki peminatan dibidang Keperawatan Maternitas. Sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai peneliti dibidang peminatan tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga telah mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristek DIKTI tahun 2021. Penulis juga aktif ikut serta dalam pelatihan yang akan mengasah kompetensi sebagai dosen. Selain peneliti, penulis juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: ilhamzhofir@gmail.com

Profil Penulis



Fitri Romadonika.,S.Kep.,Ners.,M.Kep.

Seorang penulis dan dosen tetap Program Studi Ilmu Keperawatan Jenjang S1 di INKES Yarsi Mataram. Lahir di Mataram, 28 Mei 1985. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan bapak H. Yacub Marzaen dan Ibu Hj Maemunah Alm. Menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1 Keperawatan), Profesi Ners (Ns) di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Tahun 2010 dan menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di STIKES Jendral Achmad Yani Cimahi (UNJANI) Bandung Tahun 2014. Buku yang telah di tulis dan terbit berjudul di antaranya: Pemenuhan kebutuhan Personal Hygiene, Paradigma Kesehatan di Masa Covid 19, Keperawatan Anak, Studi Kasus Aplikasi Teori Model Keperawatan, Tumbuh Kembang Anak, Kesehatan Anak (Konsep dan Penerapannya).

SINOPSIS BUKU

Kehamilan dan Kelahiran pada usia remaja berdampak pada kesehatan reproduksi karena Keadaan fisik dan pertumbuhan tubuh serta organ reproduksi yang belum sempurna menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia di bawah 20 tahun dapat menimbulkan banyak risiko. Risiko bagi kesehatan fisik meliputi komplikasi kehamilan dan risiko pada janin, komplikasi kehamilan antara lain anemia kehamilan yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi. Selain itu, pada ibu dapat menyebabkan persalinan lama, pendarahan yang lebih banyak pada saat persalinan dan masa nifas, dan produksi ASI yang berkurang. Risiko-risiko lain adalah komplikasi kehamilan seperti tekanan darah tinggi dalam kehamilan (pre-eklampsia dan eklampsia), perdarahan dalam kehamilan lanjut, perdarahan pasca persalinan dan keguguran.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di usia remaja. Gaya hidup dan perilaku seks bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja. Faktor lain adalah kurangnya informasi (keterpaparan informasi) dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) yang menyebabkan remaja tidak dapat mencari alternatif perlindungan untuk dirinya dalam mencegah kehamilan. Faktor sosial budaya, ekonomi, dukungan keluarga serta peran petugas kesehatan.

Kehamilan dan Kelahiran pada usia remaja berdampak pada kesehatan reproduksi karena Keadaan fisik dan pertumbuhan tubuh serta organ reproduksi yang belum sempurna menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia di bawah 20 tahun dapat menimbulkan banyak risiko. Risiko bagi kesehatan fisik meliputi komplikasi kehamilan dan risiko pada janin, komplikasi kehamilan antara lain anemia kehamilan yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi. Selain itu, pada ibu dapat menyebabkan persalinan lama, pendarahan yang lebih banyak pada saat persalinan dan masa nifas, dan produksi ASI yang berkurang. Risiko-risiko lain adalah komplikasi kehamilan seperti tekanan darah tinggi dalam kehamilan (pre-eklampsia dan eklampsia), perdarahan dalam kehamilan lanjut, perdarahan pasca persalinan dan keguguran.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di usia remaja. Gaya hidup dan perilaku seks bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja. Faktor lain adalah kurangnya informasi (keterpaparan informasi) dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) yang menyebabkan remaja tidak dapat mencari alternatif perlindungan untuk dirinya dalam mencegah kehamilan. Faktor sosial budaya, ekonomi, dukungan keluarga serta peran petugas kesehatan.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7137-53-5



9

786347

139535